

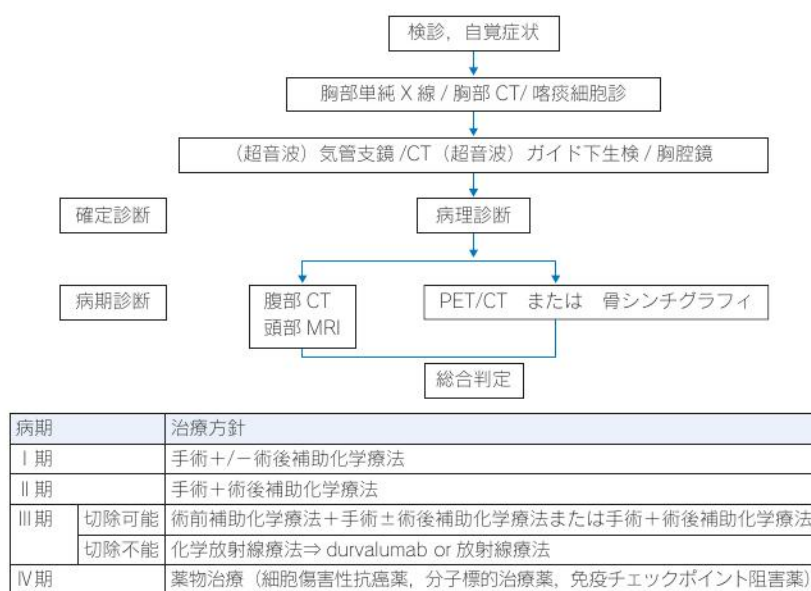


図2 肺癌の診断フローと臨床病期別治療方針

するが、IIIA 期で手術不能、IIIB 期、IIIC 期の場合は、化学療法と放射線療法の同時併用療法で増悪がない場合 durvalumab による維持療法を追加する治療が標準的治療である。IV 期の進行非小細胞肺癌に対しては年齢、全身状態、併存症の有無を考慮して化学療法、免疫チェックポイント阻害薬あるいは分子標的治療を行う。また、非小細胞肺癌症例の治療選択のうえでの重要な点は、①組織型の決定と、②EGFR 遺伝子変異、ALK 融合遺伝子、ROS1 融合遺伝子、BRAF 遺伝子変異、RET 融合遺伝子、MET 遺伝子変異、KRAS 遺伝子変異、HER2 遺伝子変異、NTRK 融合遺伝子などの個々の症例における遺伝子異常情報、さらに腫瘍組織における PD-L1 蛋白発現評価である。

#### b 外科切除可能非小細胞肺癌 (IA, IB, IIA, IIB 期)

前述したように手術療法が第一選択となる。術式は肺葉切除術 + 系統的リンパ節郭清が標準的治療である。IA 期では手術単独、IB 期以降では再発予防の目的で手術後に補助化学療法を考慮する。

#### c 外科切除可能非小細胞肺癌 (II-III B 期)

切除可能な臨床病期 II-III B 期 (第9版) の EGFR 遺伝子変異 / ALK 融合遺伝子陰性または不明例に対しては、術前にプラチナ製剤併用療法と nivolumab 療法を併用する治療が、主要評価項目である無イベント生存期間の有意な延長を示したため、この併用療法が強く推奨される。さらに、臨床病期 II-III B 期 (第9版) の症例では、術前にプラチナ製剤併用療法と pembrolizumab を併用し、術後に pembrolizumab を追加することで、主要評価項目である全生存期間の有意な延長が示された。この結果に基づき、術前にプラチナ製剤併用療法と pembrolizumab を併用し、術後

に pembrolizumab を追加する治療が強く推奨される。

#### d 手術不能非小細胞肺癌 (IIIA, IIIB, IIIC 期)

IIIA 期の切除不能例と IIIB 期、IIIC 期が含まれる。放射線治療単独による5年生存率は5%だがプラチナを含む2剤併用化学療法を追加することによる生存期間の延長が示されている。その効果は併用時期により差があり逐次併用 (放射線後に化学療法) では5年生存率は10%、同時併用では15~20%であり、特に同時併用が推奨される。放射線化学療法では肺毒性が問題となり放射線治療と併用できない薬剤もあり進行非小細胞肺癌で使用されるプラチナレジメンの一部は使用できない。臨床試験において carboplatin (CBDCA) + paclitaxel (PTX), CDDP + VNR, CDDP + docetaxel (DTX), CDDP + tegafur/gimeracil/oteracil potassium (S-1) の安全性と有用性が示されているが比較試験による至適レジメンは確立していない。また、同時化学放射線療法後、病勢がコントロールされている切除不能III期非小細胞肺癌を対象として、一年間の durvalumab による地固め療法が PFS, OS ともにプラセボに対して優越性が示された。これらの結果から化学放射線療法の効果がSD以上で、放射線肺炎がグレード1以下の症例において、durvalumab による地固め療法が推奨される。

#### e 術後化学療法

肺癌術後補助化学療法は、従来の化学療法に加え、分子標的治療薬や免疫療法の進展によって新たな局面を迎えている。術後病理病期1B期の完全切除症例では、tegafur/uracil (UFT) の内服が推奨される。それ以降の病期においては、cisplatin (CDDP) と